Včasné podanie TNF inhibítora pri periférnej spondyloartritíde prinieslo vyššiu remisiu než postupné pridávanie csDMARD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Včasný rázny zásah priniesol viac remisií než postupné pridávanie liekov.

Pri včasnej periférnej spondyloartritíde môže byť rozhodujúce, ako rýchlo sa podarí potlačiť zápal. Výsledky fázy 3 štúdie SPARTACUS naznačujú, že okamžité nasadenie TNF inhibítora môže viesť k vyššej miere klinickej remisie než štandardný postup s konvenčným syntetickým chorobu modifikujúcim liekom, konkrétne metotrexátom.

V štúdii dosiahlo klinickú remisiu po 24 týždňoch 60 % pacientov liečených golimumabom, zatiaľ čo v skupine s postupnou liečbou metotrexátom to bolo 33 %. Rozdiel bol štatisticky významný. Klinická remisia bola definovaná prísne: ako úplná neprítomnosť artritídy, daktylitídy alebo entezitídy pri klinickom vyšetrení.

Výsledky boli prezentované na výročnom kongrese EULAR 2026 a poukazujú na možnú „terapeutickú príležitosť“ v skorom štádiu ochorenia.

Prečo je periférna spondyloartritída problém

Periférna spondyloartritída je zápalové reumatické ochorenie, pri ktorom dominujú prejavy mimo chrbtice. Typicky ide o artritídu periférnych kĺbov, entezitídu alebo daktylitídu. Pacienti môžu mať výrazne opuchnuté kĺby, bolesti úponov šliach a funkčné obmedzenie.

Dôkazová základňa pre liečbu periférnej spondyloartritídy je pritom slabšia než pri axiálnej spondyloartritíde alebo psoriatickej artritíde. Podľa riešiteľov štúdie neexistuje dostatok údajov o účinnosti metotrexátu pri periférnej spondyloartritíde, hoci sa v bežnej praxi používa. Zároveň nie sú TNF inhibítory špecificky schválené pre túto diagnózu regulačnými autoritami ako FDA alebo EMA.

Bežný postup je preto konzervatívny: najprv nesteroidové antiflogistiká, následne csDMARD, napríklad metotrexát alebo sulfasalazín, a biologická liečba sa ponecháva pre refraktérne prípady.

Štúdia SPARTACUS testovala, či by skoršia intenzívnejšia liečba nemohla priniesť lepší výsledok.

Ako bola štúdia navrhnutá

SPARTACUS bola randomizovaná klinická štúdia fázy 3. Cieľom bolo zistiť, či možno u pacientov s novodiagnostikovanou, včasnou a aktívnou periférnou spondyloartritídou dosiahnuť dlhodobú remisiu bez liekov pomocou včasnej indukčnej liečby TNF inhibítorom alebo štandardnou postupnou stratégiou s csDMARD.

Do štúdie bolo zaradených 97 pacientov, ktorí spĺňali klasifikačné kritériá ASAS pre periférnu spondyloartritídu a mali príznaky kratšie než jeden rok.

Na zaradenie bola potrebná prítomnosť artritídy, entezitídy alebo daktylitídy a aspoň jeden ďalší znak spondyloartritídy.

Charakteristika pacientov na začiatku:

- 97 % malo artritídu,
- 68 % malo entezitídu,
- 34 % malo daktylitídu,
- priemerný vek bol 39 rokov,
- 60 % tvorili muži,
- 45 % bolo HLA-B27 pozitívnych,
- 51 % malo anamnézu psoriázy,
- priemerné trvanie príznakov bolo 5,9 mesiaca.

Pacienti boli rozdelení do dvoch liečebných stratégií. Prvá skupina dostávala golimumab 50 mg subkutánne každé 4 týždne. Druhá skupina dostávala metotrexát perorálne v úvodnej dávke 15 mg týždenne, s navýšením na 20 mg týždenne po 4 týždňoch, ak bol liek tolerovaný.

Ak pacienti po 12 týždňoch nedosiahli remisiu a ich ťažkosti neboli dostatočne kontrolované, mohol byť do liečby pridaný sulfasalazín v dávke 2 g denne.

Golimumab dosiahol vyššiu mieru remisie

Po 24 týždňoch bola klinická remisia významne častejšia v skupine s okamžitým podaním TNF inhibítora.

Výsledky:

- 60 % pri golimumabe,
- 33 % pri postupnej stratégii s metotrexátom,
- odds ratio 3,1,
- $P = 0{,}006$.

Udržaná klinická remisia po 24 týždňoch bola takisto častejšia pri TNF inhibítore:

- 42 % pri golimumabe,
- 18 % pri csDMARD stratégii,
- $P = 0{,}006$.

Tento rozdiel podporuje hypotézu, že včasné potlačenie zápalu môže byť pri periférnej spondyloartritíde klinicky výhodné.

Zlepšili sa aj jednotlivé prejavy ochorenia

Pacienti liečení golimumabom mali vyššiu pravdepodobnosť ústupu artritídy, entezitídy aj daktylitídy. Rozdiely medzi skupinami boli viditeľné už od 8. týždňa a pretrvávali do 24. týždňa.

Podobný trend sa pozoroval aj pri hodnotení aktivity ochorenia pomocou skóre DAPSA a ASDAS-CRP. V oboch ukazovateľoch boli poklesy výraznejšie pri TNF inhibítore než pri metotrexáte.

Zaujímavé je, že CRP sa znížilo v oboch skupinách približne podobne. Vstupne bolo zvýšené, s priemerom okolo

25 mg/l, a pri oboch liečebných stratégiách kleslo približne na 5 mg/l.

To naznačuje, že metotrexát nebol neúčinný. Aj on mal merateľný efekt, len klinická odpoveď bola pri okamžitom podaní TNF inhibítora výraznejšia.

Metotrexát napriek tomu nie je bez významu

Jedným z dôležitých odkazov štúdie je, že metotrexát v periférnej spondyloartritíde zrejme „niečo robí“. Podľa riešiteľa Philippa Carrona je to prvý dôkaz, že metotrexát má pri tejto diagnóze účinok, čo je povzbudivé, keďže sa používa v každodennej praxi.

To je prakticky dôležité. Výsledky neznamenajú, že metotrexát treba opustiť. Skôr ukazujú, že ak je cieľom rýchla a hlboká remisia pri včasnej aktívnej periférnej spondyloartritíde, TNF inhibítor môže byť účinnejšou indukčnou stratégiou.

Zároveň bolo menej pacientov v skupine s golimumabom, ktorí potrebovali záchranné pridanie sulfasalazínu po 12 týždňoch:

- 8,3 % pri golimumabe,
- 28,6 % pri metotrexáte,
- $P = 0,02$.

Bez výrazného bezpečnostného signálu v prvých 24 týždňoch

Počas prvých 24 týždňov neboli v štúdii zaznamenané nové významné bezpečnostné signály. V skupine s TNF inhibítorom sa vyskytla jedna závažná nežiaduca udalosť: chrípkové príznaky vyžadujúce hospitalizáciu. Inak neboli hlásené závažné nežiaduce udalosti v žiadnej zo skupín.

Pri interpretácii bezpečnosti však treba byť opatrný. Štúdia mala 97 pacientov a sledovanie v tejto analýze trvalo 24 týždňov. Takýto rozsah je užitočný na zachytenie častých problémov, ale nestačí na definitívne hodnotenie zriedkavých alebo dlhodobých rizík.

Čo to znamená pre klinickú prax

Výsledky podporujú myšlienku skoršej intenzívnej liečby pri včasnej periférnej spondyloartritíde. Ak sa podarí ochorenie zachytiť v prvých mesiacoch, môže existovať okno príležitosti, v ktorom agresívnejšie potlačenie zápalu zlepší šancu na remisiu a možno aj na prevenciu štrukturálneho poškodenia.

To je dôležité najmä preto, že periférna spondyloartritída môže viesť k chronickej bolesti, poškodeniu kĺbov, strate funkcie a zhoršeniu kvality života.

Výsledky však treba čítať triezvo. SPARTACUS ukazuje superioritu okamžitého TNF inhibítora oproti postupnej (step-up) stratégii s metotrexátom v 24. týždni, ale neodpovedá ešte definitívne na otázku dlhodobej remisie bez liekov, rádiografickej progresie ani optimálnej ekonomickej stratégie.

Praktický záver

Štúdia SPARTACUS ukázala, že u pacientov s včasnou aktívnou periférnou spondyloartritídou viedla okamžitá liečba golimumabom k vyššej miere klinickej remisie po 24 týždňoch než postupná stratégia s metotrexátom.

Najdôležitejšie posolstvá sú tri:

- včasná diagnostika periférnej spondyloartritídy má praktický význam,
- skoré podanie TNF inhibítora môže priniesť vyššiu šancu na remisiu,
- metotrexát pravdepodobne nie je neúčinný, ale jeho efekt bol v tejto štúdii slabší než pri golimumabe.

Pre klinickú prax to otvára otázku, či by časť pacientov s včasnou, aktívnou a klinicky výraznou periférnou spondyloartritídou nemala dostať biologickú liečbu skôr, než to umožňuje tradičný postupný model.

Zdroj: *Medscape, TNF Inhibitor Use in Early Peripheral Spondyloarthritis (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=tnf-inhibitor-vcasna-periferna-spondyloartritida-spartacus · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.